ICS **.***.**
C**

团体标准

T/CACM****.3
代替 ZYYXH/T 447-2015

奔豚气中医诊疗指南

Chinese medicine diagnosis and treatment guide for Up-rushing gas syndrome

（文件类型：公示稿）

（完成时间：20**年*月）

20**-**-**发布 20**-**-**实施

中 华 中 医 药 学 会 发 布

目　次

前言 ..... Ⅰ
引言 ..... Ⅱ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 诊断 1
5 中医证候分型 2
6 治疗 2
7 结局（预后） 4
8 注意事项 4
参考文献 5

前　言

本文件参照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件在中华中医药学会 2015 年发布的《中医神志病临床诊疗指南·奔豚气》（标准号：ZYYXH/T447-2015）基础上修订，与前一版相比，本文件结合近年来国内外临床研究证据，重新进行证据分级和意见推荐，经过专家讨论，形成具有指导临床诊疗奔豚气的中医临床实践指南。主要变化如下：

a） 更改指南名称“中医神志病临床诊疗指南·奔豚气”为“奔豚气中医诊疗指南”（见封面）；

b）更改“范围”的表述（见 1，2015 版见 1）；

c）增加“规范性引用文件”（见 2）；

d）更改“术语与定义”的表述（见 3，2015 版见 2）；

e）增加“中医诊断标准”（见 4.1）；

f）补充“鉴别诊断”（见 4.4，2015 版见 3.2）；

g）更改“肝郁化火证”为“肝郁化热证”，并更改临床表现（见 5.1，2015 版见 4.1）；

h）更改“肝郁化热证”的治法以及处方加减（见 6.2.1，2015 版见 5.2.1）；

i）增加煎药方法（见 6.2）；

j）更改“其他疗法”中的“针灸疗法”，增加“电针疗法”和“中医情志治疗”，删除“饮食疗法”（见 6.3，2015 版见 5.3）；

k）增加“结局（预后）”（见 7）；

l）增加“注意事项”（见 8）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华中医药学会神志病分会提出。

本文件由中华中医药学会归口。

本文件起草单位：黑龙江神志医院、黑龙江省精神心理卫生研究中心、吉林大学药学院、浙江省立同德医院、黑龙江省妇幼保健院、沈阳市精神卫生中心、新疆维吾尔族自治区中医医院、长春中医药大学附属医院、上海市中西医结合医院、北京中医药大学第三附属医院、无锡市精神卫生中心、西安市精神卫生中心、河南省中医药研究院附属医院、沈阳市安宁医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京中医药大学东方医院、复旦大学附属中山医院、黑龙江中医药大学。

本文件主要起草人：于明、柴剑波、刘郦莹、白冰、赵永厚、孙伟毅、赵玉萍、都弘、陈俊逾、王健、冯蓓蕾、赵瑞珍、王群松、李宝君、范军铭、高德江、贾竑晓、王国才、李卡、杨炳友。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2015 年首次发布为《中医神志病临床诊疗指南·奔豚气》（标准号：ZYYXH/T447-2015）；

——本次为第一次修订。

引 言

中医神志病学是中医学学科体系中的重要组成部分，尤其是随着现代医学模式的转变，精神卫生工作的重要性日益凸显，中医神志病学成为充分发挥中医药在精神卫生防治中的作用及特色优势的重要阵地。而标准化、规范化和客观化是医疗技术质量管理的基础，是进行临床、科研活动评价的参照标准，是学科健康有序发展的保障，亦是反映学科成熟度的重要指标。因此，开展中医神志病临床诊疗技术的标准化研究工作，是中医神志病学现代化发展的首要任务和重要内容。

《奔豚气中医诊疗指南》以中医药临床诊疗的作用与优势发挥为基础，在中华中医药学会 2015 年发布的《中医神志病临床诊疗指南·奔豚气》（标准号：ZYYXH/T447-2015）基础上，再次系统整理国内外中医药及治疗奔豚气的治疗方案及经验，借鉴循证医学的方法，对奔豚气的近几年临床研究文献和古籍文献进行分级及意见推荐，形成中医防治奔豚气的临床实践指南，对于规范使用中医药方法、提高奔豚气的临床疗效具有重要作用。

奔豚气中医诊疗指南

1 范围

本文件规定了奔豚气的定义、临床特征、诊断标准、治疗方案。

本文件适用于奔豚气中医临床诊疗。

本文件的使用环境：中医院、中西医结合医院、精神专科医院、综合医院、基层医院的神志病科、精神科、心理科、心身科等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14396-2016《疾病分类与代码》

GB/T 15657-2021《中医病证分类与代码》

GB/T 16751.1-2020《中医临床诊疗术语 第 1 部分：疾病》

GB/T 16751.2-2020《中医临床诊疗术语 第 2 部分：证候》

GB/T 16751.3-2020《中医临床诊疗术语 第 3 部分：治法》

GB/T 7714-2015《文后参考文献著录规则》

GB/T 13016-2018《标准体系表编制原则和要求》

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

奔豚气 Up-rushinggassyndrome

奔豚气是因情志内郁，心肾阳虚，气机逆乱上冲所引起的一类阵发性形神失和类神志疾病。以气从少腹上冲胸、心、咽喉，发作欲死，复还止等表现为特征的一类疾病。相当于精神病学中“癔病”、“神经官能症”等。

4 诊断

4.1 中医诊断标准

奔豚气的中医证候诊断，主要通过临床望、闻、问、切四诊信息进行辨证，并将中医辨证体系中的八纲辨证、脏腑辨证、气血津液辨证相结合。

（1）曾受过惊恐刺激；

（2）症见气从少腹上冲胸、心，甚者咽喉，其势如豚之奔跑，惊恐不安，常伴胸闷气憋欲死，发作后恢复正常；

（3）一般神志清楚，意识无碍；

（4）发作时间可持续数秒至数十分钟。

4.2 临床表现

自觉有“气”从少腹向上冲逆至咽喉，其势如豚之奔跑，惊恐不安，胸闷气憋欲死，发作后恢复如常，伴有紧张、恐惧、焦急等情绪变化。

4.3 辅助检查

一般体格检查、神经系统检查及实验室检查排除其他躯体性疾病，发作时头颅 CT、MRI 和脑电图检查排除其他器质性病变。汉密尔顿抑郁量表、汉密尔顿焦虑量表对本病的诊断有参考作用。

4.4 鉴别诊断

奔豚气当与肾积奔豚、脐下悸动、惊悸、冲疝作出鉴别。

5 中医证候分型

主要参考中国中医药出版社 2016 年出版的《中医神志病学》[1]，临床常见证候如下：

5.1 肝郁化热证

自觉有气从少腹上冲至胸，腹痛，往来寒热，烦闷不适，伴郁郁寡欢，胸胁满闷，口苦咽干，常欲叹息，性急易怒，舌边尖红，舌苔薄白或薄黄，脉弦数。

5.2 心肾阳虚证

自觉气从少腹上冲胸咽，畏寒喜热，心悸不安，胸闷气促，窒息欲死，痛苦异常，四肢欠温，面色苍白，腹痛，舌质淡白，苔自腻，脉沉迟。

5.3 寒饮上逆证

自觉气从少腹上冲胸咽，心悸短气，恶心欲呕，痛苦异常，难以名状，或咳嗽痰稀，胸胁支满，头晕目眩，舌质淡，苔白腻，脉沉弦。

5.4 水气上冲证

自觉气从少腹上冲胸咽，发作欲死，或脐下动悸，欲作奔豚，或头眩短气，口吐涎沫，小便不利，舌质淡，苔白滑，脉沉弦。

6 治疗

6.1 治疗原则

奔豚气的治疗应以平冲降逆，安神定志为总的治疗原则。虚者治以补肾助阳，温化寒饮之法；实者治以疏肝解郁，清热降火之法[2-8]。

6.2 辨证论治

6.2.1 肝郁化热证

治法：调肝解郁，泻热平冲。

方药：奔豚汤[9-19]（《金匮要略》）加减。（高级证据，强推荐）

常用药：甘草、川芎、当归、黄芩、半夏、生葛根、白芍、生姜、甘李根白皮。若临床难寻甘李根白皮，可用川楝子或桑白皮代。

加减：若肝郁化火明显者，症见烦躁不安，舌红苔黄，加丹皮、炒栀子清热凉血；若腹痛明显者，加川楝子、延胡索理气止痛；胸胁满闷不适较重者，加枳壳、瓜壳理气宽胸；若烦躁不安、情志不舒者，加合欢花、郁金疏肝解郁。

6.2.2 心肾阳虚证

治法：温阳祛寒，降逆平冲。

方药：桂枝加桂汤[20-24](《金匮要略》)加减。（中级证据，强推荐）

常用药：桂枝、白芍药、甘草、生姜、大枣。

加减：心烦不宁者，重用生龙骨（先煎）、生牡蛎（先煎）；心悸者，加麦冬、玉竹、五味子；胸闷气促伴窒息欲死者，加丹参、赤芍、桃仁、红花。

6.2.3 寒饮上逆证

治法：温化寒饮，降逆平冲。

方药：当归四逆汤[25]（《伤寒论》）合吴茱萸汤(《金匮要略》)加减。（低级证据，弱推荐）

常用药：半夏、吴茱萸、生姜、桂枝、人参（另煎）、甘草。

加减：寒饮不化者，可与苓桂术甘汤合用；咳痰清稀者，可与苓甘五味姜辛汤合用；若奔豚气反复发作难愈者，加沉香（后下）、黑锡。

6.2.4 水气上冲证

治法：通阳降逆，培土制水。

方药：茯苓桂枝甘草大枣汤[26](《金匮要略》)加减。（低级证据，弱推荐）

常用药：茯苓、桂枝、甘草、大枣。

加减：水气内动奔豚已作者，可与桂苓五味甘草汤合用。

6.3 中医非药物治疗

6.3.1 针刺治疗

肝郁化热者，主穴：公孙、内关、太冲、期门、膻中、中脘、行间。配穴：兼心神失养者配定神针

及神门。操作：太冲、行间、期门、膻中、公孙、内关用泻法；中脘、神门用补法。

心肾阳虚者，主穴：阴交、中极、石门、膻中、鸠尾。配穴：属心阳不振者配心俞，属肾阳虚衰者配关元。操作：膻中透刺鸠尾，中极用温针灸，石门、阴交用泻法。

寒饮上逆者，主穴：阴交、水分、关元、肾俞、神门、阴陵泉。配穴：兼心脾两虚者配心俞、脾俞。操作：阴交用泻法，水分、关元、肾俞用温针灸，神门用补法，阴陵泉用泻法。

针刺均以得气为度，而后留针 30min，每 10min 实施提插捻 1 次。每日 1 次，疗程 2～4 周。[27-29]

6.3.2 电针疗法

取天枢、水分、阴交穴,简称脐周三穴。治疗采用 1.5～2 寸毫针，选准穴位，经皮肤消毒后刺入 1.5～2 寸。采用平补平泻捻转手法，针感要求天枢穴传向腹股沟，水分穴传向胃院部和脐下，阴交穴传向下腹部，得气后加电针，疏密波，30min 后出针，每日 1 次，10 次为疗程。[30]（低级证据，强推荐）

6.3.3 中医情志疗法

若患者有明显的惊恐经历，当驱除或减弱其影响或记忆为主。可以采用《内经》的“惊者平之”法治疗，此法与现代心理学的系统脱敏疗法相似。此法辨证施用，因人而异。

7 结局（预后）

一般而言，奔豚气若治疗及时得当，一般预后良好。若初受惊恐后能及时得到关爱抚慰，心理治疗及调整，惊恐气逆乱及时化解，以后则较少发为奔豚气，预后较好，或发而轻微。若初受惊恐得不到化解，甚者反复经历惊恐刺激，工作生活环境恶劣，气逆乱得到强化，治疗护理不当，日久则会发为较为严重的奔豚气，易反复发作，预后较差。

8 注意事项

应用本文件时应先明确诊断，本文件不能应用于除奔豚气外的其他疾病，注意区分肾积奔豚、脐下悸动、惊悸、冲疝等疾病，以免发生诊疗错误，影响患者的转归及预后；临床医务人员当根据患者具体情况，灵活更改治疗方案，不可拘泥于本文件。

参 考 文 献

[1]赵永厚.中医神志病学[M].全国中医药行业高等教育“十三五”创新教材.北京:中国中医药出版社.2016，10:348-356.

[2]程敏，李赛美.论奔豚气病的发病与治疗[J].江苏中医药，2019，51(05):53-55.

[3]徐成贺.奔豚病验案介绍与临证心得[J].国医论坛，2016，31(06):6-8.

[4]朱锦如，郭闫葵.奔豚气与癫痫痰气并治的治疗思路[J].中国中医药现代远程教育，2018，16(05):70-71.

[5]温霏，张珊珊，时吉来.曹志群教授运用桂枝加龙骨牡蛎汤加减配合针灸治疗奔豚气验案举隅[J].世界最新医学信息文摘，2018，18(58):212-214.

[6]李琤.温阳固肾降逆法治疗类奔豚病 1 例[J].实用中医药杂志，2018，34(01):117-118.

[7]赵作伟.奔豚气治验[N].中国中医药报，2017-07-26(005).

[8]郭敏，陈宝贵.陈宝贵教授治疗奔豚气验案举隅[J].内蒙古中医药，2017，36(03):59.

[9]王志忠.奔豚汤联合曲美布汀对伴有焦虑状态的腹泻型肠易激综合征患者的影响[J].中国民间疗法，2019，27(04):55-57.

[10]王志忠.奔豚汤治疗胃神经官能症[J].中国民间疗法，2009，17(12):31-32.

[11]杨晓，刘平.奔豚汤治疗焦虑性神经官能症 26 例[J].陕西中医，2007，307(07):879.

[12]申广生，张炜.奔豚汤加减治疗小儿多发性抽动症气郁化火型临床观察[J].实用中医药杂志，2018，308(09):1040-1041.

[13]秦成波.中西医结合治疗失眠症 44 例[J].世界最新医学信息文摘，2016，16(11):134-135.

[14]李瑛，陈柏谦.加味奔豚汤联合西药治疗肝郁化火型失眠疗效观察[J].实用中医药杂志，2015，274(11):1024-1025.

[15]王峰.加味奔豚汤治疗痰气郁结、热扰心神型广泛性焦虑症的临床研究[D].山东中医药大学，2015.

[16]史先芬，吴自光.加味奔豚汤治疗中风后抑郁 55 例疗效观察[J].中医临床研究，2013，5(12):29+31.

[17]侯合云.中西医结合治疗失眠症疗效观察[J].基层医学论坛，2012，323(23):3083-3084.

[18]朱翠玲.奔豚口服液治疗心脏神经官能症 60 例[J].中医杂志，2003，(07):528-529.

[19]肖宝香，靖永义.奔豚汤加减配合西药治疗惊恐障碍的临床观察[A].中国中医药研究促进会、山东针灸学会.中国中医药研究促进会针灸康复分会第二届学术年会暨山东针灸学会第九届学术年会论文集[C].中国中医药研究促进会、山东针灸学会:山东针灸学会，2017:3.

[20]王亚.桂枝加桂汤治疗虚寒型腹痛 50 例[J].陕西中医函授，2001，(06):22.

[21]张鹏，万强.桂枝加桂汤加减治疗胃食管反流病 36 例[J].山西中医，2015，31(02):39+41.

[22]杜世华.桂枝加桂汤加减治疗顽固性呃逆[J].山西中医，2007，(01):14.

[23]泮晓波.桂枝加桂汤治疗胸口发冷 51 例[J].江西中医药，2006，(02):46.

[24]邢俊梅.桂枝加桂汤治疗顽固性奔豚气的体会[J].中国中医急症，2015，24(09):1685-1686.

[25]廖美容，周义杰，苏丹，王培力.当归四逆汤联合盐酸帕罗西汀治疗躯体形式疼痛障碍疗效分析[J].新中医，2013，475(12):75-77.

[26]毕春和，刘春贵.苓桂甘枣汤加味治疗非器质性心脏病室性早搏 45 例[J].云南中医中药杂志，2011，222(12):48.

[27]王学利，张飞，王国军，李希星.浅针多刺开络行气针法治疗奔豚气 11 例临床观察[J].中国社区医师，2017，33(23):103+105.
[28]胡江涛，王思颖.董氏奇穴治疗奔豚气案[J].中国民间疗法，2019，27(21):90.
[29]张蕊，董旭，宋晶，何雷，王东岩.奔豚气案[J].中国针灸，2017，37(12):1357.
[30]张泉香.电针脐周三穴治疗奔豚气 42 例[J].中国针灸，2002，22(S1):41-42.